Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de São Vicente do Sul

Rua Vinte de Setembro, 775 - Bairro: Centro - CEP: 97420000 - Fone: (55) 302-99992 - Email: frsaovicevjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5000250-44.2024.8.21.0131/RS

REQUERENTE: NOEMIA CHIMENDES DE OLIVEIRA
REQUERENTE: JOSUE DE OLIVEIRA
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

JOSUE DE OLIVEIRA, representado por sua genitora **NOEMIA CHIMENDES DE OLIVEIRA**, ajuizou **ação para fornecimento de medicamento** com pedido de tutela de urgência em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador da(s) patologia(s) de CID 10 - F70 (Retardo mental leve), necessitando realizar tratamento contínuo com o fármaco **DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG- 01 comprimido por dia**; todavia não dispõe de condição financeira para custear o tratamento. Fundamentou o direito na Constituição Federal, na Carta Estadual, na Lei n.º 8.080/90, na Lei Estadual n.º 9.908/83 e na Lei n. 12.401/2011. Requereu, em sede de tutela antecipada, o imediato fornecimento do medicamento mencionado na inicial. Postulou ao final, dentre outros pedidos, pela procedência da demanda. Vindicou a AJG. Juntou documentos (evento 1).

Recebida a inicial, deferida a AJG e indeferida a antecipação de tutela (evento 03).

Da decisão o autor interpôs agravo de instrumento, sendo deferidaa tutela de urgência recursal (evento 25).

Citado, o ERGS apresentou contestação, ocasião em que teceu considerações sobre o pedido em face do poder público, referindo que não houve comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; bem como sobre a necessidade de exames períodicos e observânca da denominação comum brasileira. Discorreu sobre os honorários e custas processuais para o caso de procedência da demanda. Postulou, dentre outros pedidos, pela improcedência da lide (evento 27).

Houve réplica (evento 31).

As partes foram intimadas sobre a produção de provas (evento 37).

A parte ré requereu a produção de provas (evento 42), enquanto a parte autora, nada requereu (evento 54).

Houve o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234 do STF (evento 69).

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido exordial (evento 64).

Após o julgamento do Tema 1.234, foi converto o julgamento do feito em diligência e oportunizada a parte autora a adequação aos critérios estabelecidos no tema (evento 80).

Manifestou-se a parte autora (evento 83).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Cuida-se de ação pela qual a autora requer o fornecimento de **DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG**, por apresentar patologia classificada pelo **CID 10 - F70 (Retardo mental leve)**, medicamento não disponibilizado pelo SUS.

No mérito, registro que o direito à saúde é reconhecido constitucionalmente como sendo um direito fundamental do cidadão, na medida em que vem elencado no rol de direitos sociais do art. 6º da CF/88.

A matéria também vem disciplinada em seu art. 196, ao dispor que:

> *"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso natural e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".*

Para o cumprimento desse dever constitucional, o Estado brasileiro criou o Sistema Único de Saúde (198, § 1º, da CF[1]) que, por ser universal e gratuito, está amparado na lógica da medicina de evidência, estabelecendo protocolos e diretrizes para a prestação mais efetiva possível com o menor dispêndio de recursos públicos.

Desse modo, se a demanda objetiva uma prestação já reconhecida como integrante do Sistema Único de Saúde, o direito subjetivo do cidadão afigura-se com máxima força; de outro lado, se a demanda tem por objeto prestação não integrante das políticas públicas, está sujeita à ponderação, pois com o direito invocado competem vários outros princípios, e a efetivação somente pode se realizar no limite das possibilidades fáticas e jurídicas do caso.

No caso concreto, o fármaco **DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 30MG**, não faz parte dos elencos de medicamentos disponibilizados pelo SUS, conforme certidão negativa de **evento 1, OUT5, p. 2**.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o **Tema n.º 6** e o **Tema n.º 1234**, definiu diversos critérios para o fornecimento judicial de medicamentos.

A partir dos referidos Temas foram editadas as Súmulas Vinculantes n.º 60 e 61, as quais transcrevo:

Súmula Vinculante n.º 60

O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), ***devem observar*** *os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).*

Súmula Vinculante n.º 61

A concessão judicial de ***medicamento*** *registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,* ***deve observar*** *as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).*

Considerando que a demanda visa o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, é necessário observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). São elas:

"1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. ***É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.*** *3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS."*

À parte autora foi oportunizada a produção de provas, especificamente para comprovar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Ainda, para comprovar a existência de relatório da Conitec recomendando ou não o uso do medicamento para tratamento da patologia e, em caso de parecer desfavorável, apontar eventual vício de regularidade do procedimento e/ou de legalidade do ato de não incorporação.

Contudo, a parte autora limitou-se a informar que existe relatório desfavorável da Conitec e que este não se aprofunda quanto a utilização da medicação para a doença que acomete a parte autora, discorrendo acerca dos benefícios para o tratamento da parte autora (evento 83).

Destarte, concernente ao item "a" do tópico 2, das teses acima transcritas, observo a presença de certidão que indeferiu o fornecimento do medicamento na via administrativa (**evento 1, OUT5, p. 2**).

Já no que tange ao item "b" do tópico 2, ressalta-se que há relatórios da Conitec[1] opinando pela não incorporação do fármaco ao SUS, haja vista que o dimesilato de lisdexanfetamina foi considerado como de baixo grau de confiança das evidências e o elevado impacto orçamentário, vejamos:

"Recomendação inicial da Conitec

A Conitec recomendou inicialmente a não incorporação no SUS do dimesilato de lisdexanfetamina para o tratamento de pacientes adultos com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). O tema foi discutido durante a 95ª reunião ordinária da Comissão, realizada nos dias 3 e 4 de março de 2021. Para o Plenário, o número pequeno de participantes registrado na maior parte dos estudos primários, o curto tempo de acompanhamento (máximo 20 semanas), o grau de confiança das evidências (avaliado como baixo e muito baixo) e o elevado impacto orçamentário foram aspectos importantes para a tomada de decisão preliminar sobre o tema (...)

Resultado da consulta pública

Foram recebidas 67 contribuições, sendo 13 técnico-científicas e 54 sobre experiência ou opinião. Após apreciação das contribuições, o Plenário da Conitec entendeu que não foram apresentadas novas evidências que mudassem o entendimento sobre o tema. ***A recomendação inicial, desfavorável à incorporação, foi mantida****. (...)*

Decisão final

Com base na recomendação da Conitec, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições legais, ***decidiu não incorporar o dimesilato de lisdexanfetamina para indivíduos adultos com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.***

Vale mencionar que a decisão acima mencionada foi proferida por órgão técnico, de abrangência nacional, legalmente instituído na atribuição de avaliar a incorporação de novas tecnologias no âmbito do SUS.

Na mesma linha, destaca-se o Enunciado 103 do CNJ:

"Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia, a determinação judicial de fornecimento deve apontar o fundamento e a evidência científica que afaste a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente. "

Muito embora o relatório da Conitec tenha analisado a possibilidade de incorporação do medicamento para tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, a parte autora é acometida de CID 10 F 70- Retardo Mental Leve.

Assim, tenho que, diante dos novos contornos trazidos pelo Tema 1.234, ante a inexistência de relatório da CONITEC para a doença da parte autora, deveria a parte autora apresentar evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) que comprovassem a segurança e a eficácia do fármaco, em atenção aos itens 4.3 e 4.4 da tese fixada.

Contudo, limitou-se a apresentar Relatório de Recomendação Preliminar desfavorável à incorporação no SUS do medicamento postulado em razão da baixa eficácia e segurança e elevado aporte de recursos financeiros, além de estudo acerca da segurança e eficácia do uso do farmaco para o tratamento de TDAH, a qual, reiteres-se, não é a patologia apresentada pelo autor.

Dessa forma, forçoso concluir que a parte autora não se desincumbiu de atender os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234, SV n.º 60 e 61, sendo caso de improcedência do pedido.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido apresentado por **JOSUE DE OLIVEIRA** em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

Revogo a decisão liminar de evento 25.

Sem custas processuais, por se tratar de feito atinente à Infância e Juventude, nos termos do art. 141, §2º, do ECA (Lei nº 8.069/90).

Condeno o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 300,00, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde a publicação da presente sentença e de juros de mora de 1% ao mês, capitalizados anualmente, a partir do trânsito em julgado, considerando os vetores dispostos no art. 85, § 2º do CPC.

Contudo, suspendo a exigibilidade do pagamento da referida condenação, forte no que dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que ora defiro.

Publicação e intimação automáticas.

Interposta a Apelação pela parte autora/requerida, intime-se a parte adversa para contrarrazões.

Com a juntada das contrarrazões, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **VALERIANO SANTOS FILHO, Juiz de Direito**, em 17/12/2024, às 21:40:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10074026962v15** e o código CRC **f31f0750**.

---

1. "O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes". ↩

1. https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2021/Sociedade/20210602_resoc248_lisdexanfetamina_tdah_final.pdf ↩